

TEMA 4.16 • GASTROENTEROLOGÍA

Abdomen Agudo de Origen Vascular

PERFIL EUNACOM 1.06.2.001
Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Hernia Diafragmática, Hernia Hiatal y Tumores del Mediastino

1. Hernia Diafragmática Traumática

Causa

- **Trauma** (toracoabdominal), abierto o cerrado — es la única causa en el adulto
- Si el trauma es abdominal → diafragma se rompe hacia el tórax
- Si el trauma es torácico → puede romperse hacia abajo (menos frecuente)

Clínica

TABLA 4.16.1: FASE VS CLÍNICA	
FASE	CLÍNICA
Aguda	Asintomática (síntomas ocultos por el traumatismo en sí) o dolor
Crónica	Generalmente asintomática; riesgo de obstrucción/encarceración intestinal

NOTA CLÍNICA
La hernia diafragmática traumática puede pasar inadvertida en el trauma agudo porque el dolor del traumatismo mismo la enmascara.

Diagnóstico

- **Radiografía de tórax:** presencia de asas intestinales dentro del tórax (imagen más característica)
- También puede ser hallazgo durante exploración quirúrgica del tórax o abdomen

Tratamiento

TABLA 4.16.2: FASE VS TRATAMIENTO	
FASE	TRATAMIENTO
Aguda	Cirugía de urgencia (reparación del diafragma)
Crónica	Cirugía electiva (si no complicada); urgente si se complica (obstrucción)

2. Hernia Hiatal (Hernia al Hiato Esofágico)

Clasificación — Clave EUNACOM

TABLA 4.16.3: TIPO VS NOMBRE				
TIPO	NOMBRE	FRECUENCIA	CLÍNICA	TRATAMIENTO
Tipo I	Deslizamiento	> 95%	Asintomática o RGE	Si RGE → tratar el RGE; si no → observar
Tipo II	Paraesofágica	< 5%	Puede complicarse (obstrucción, encarceración)	Cirugía electiva

EUNACOM CRITERIOS
Tipo I (deslizamiento) es tan frecuente que se considera casi normal. NO se opera salvo que produzca RGE refractario. **Tipo II (paraesofágica)** es una hernia verdadera → se opera siempre (electiva) porque puede encarcerarse.

3. Tumores del Mediastino

Clasificación por Localización

El mediastino se divide en **anterior, medio y posterior:**

TABLA 4.16.4: MEDIASTINO VS TUMORES MÁS FRECUENTES	
MEDIASTINO	TUMORES MÁS FRECUENTES
Anterior	Las 4T: Timoma, Terrible linfoma, Teratoma, Tiroides
Medio	Pericárdicos, cáncer bronquial
Posterior	Tumores nerviosos: Neurinomas, Neurofibromas, Schwannomas

PERLA CLÍNICA EUNACOM
Regla de las 4T para mediastino anterior: 1. Timoma (más frecuente del mediastino anterior) 2. Terrible linfoma (linfoma — incluye Hodgkin y no-Hodgkin) 3. Teratoma (tumor de células germinales) 4. Tiroides (ectópica o extensión)

Diagnóstico

- **Radiografía de tórax** → mediastino ensanchado o masa
- **TAC de tórax** → examen de elección para caracterizar tumores mediastínicos (también para mediastinitis)

Tratamiento del Timoma (el más importante)

TABLA 4.16.5: SITUACIÓN VS TRATAMIENTO	
SITUACIÓN	TRATAMIENTO
Asintomático	Observación (benigno, de crecimiento lento)
Asociado a Miastenia Gravis	Cirugía (timectomía)

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN
Miastenia Gravis + Timoma = indicación quirúrgica. La miastenia gravis es la complicación autoinmune clásica del timoma. La timectomía puede mejorar o curar tanto el timoma como la miastenia.

Tratamiento según tipo de tumor

TABLA 4.16.6: TUMOR VS TRATAMIENTO	
TUMOR	TRATAMIENTO
Linfoma	Quimioterapia (+ radioterapia)
Neurinoma (benigno)	Observación o resección si crece
Teratoma	Cirugía

| Timoma | Observación (o cirugía si MG asociada) |

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM
ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:
"Paciente de 72 años con fibrilación auricular que presenta dolor abdominal súbito muy intenso. El examen abdominal no muestra signos peritoneales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?"
EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:
Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Abdomen Agudo de Origen Vascular. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Embolia mesentérica: FA + dolor súbito intenso SIN signos peritoneales → angiografía + anticoagulación + embolectomía
- Trombosis venosa mesentérica: dolor subagudo (3-5 días) CON signos peritoneales → TAC con contraste + heparina
- Colitis isquémica: dolor en hipocondrio izquierdo (ángulo esplénico) → TAC
- Manejo general: suero fisiológico + ceftriaxona + metronidazol + cirugía si necrosis/perforación
- Embolia mesentérica: anticoagular ante la sospecha (heparina)

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ABDOMEN AGUDO DE ORIGEN VASCULAR)**PREGUNTA 1**

Paciente de 72 años con fibrilación auricular que presenta dolor abdominal súbito muy intenso. El examen abdominal no muestra signos peritoneales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A)** Apendicitis aguda
- B)** Embolia mesentérica
- C)** Diverticulitis aguda
- D)** Pancreatitis aguda
- E)** Úlcera perforada

PREGUNTA 2

¿Cuál es el examen diagnóstico de elección para la embolia mesentérica?

- A)** TAC de abdomen simple
- B)** Ecografía abdominal
- C)** Angiografía mesentérica
- D)** Colonoscopia
- E)** Radiografía de abdomen

PREGUNTA 3

Paciente con dolor abdominal de 4 días de evolución, predominantemente en mesogastrio, con signos peritoneales y hematoquecia. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A)** Embolia mesentérica
- B)** Trombosis venosa mesentérica
- C)** Colitis isquémica
- D)** Diverticulitis aguda
- E)** Enfermedad de Crohn

RESUMEN: ABDOMEN AGUDO DE ORIGEN VASCULAR

Clase sobre las tres causas vasculares de abdomen agudo. Embolia mesentérica: antecedente de fibrilación auricular, dolor súbito intenso SIN signos peritoneales al inicio, diagnóstico con angiografía, tratamiento con anticoagulación + embolectomía/trombólisis. Trombosis venosa mesentérica: dolor subagudo (3-5 días) con signos peritoneales, diagnóstico con TAC con contraste, tratamiento con anticoagulación. Colitis isquémica: dolor en hipocondrio izquierdo (ángulo esplénico), diagnóstico con TAC. Manejo general para las tres: hidratación IV, antibióticos (ceftriaxona + metronidazol), cirugía si necrosis o perforación.